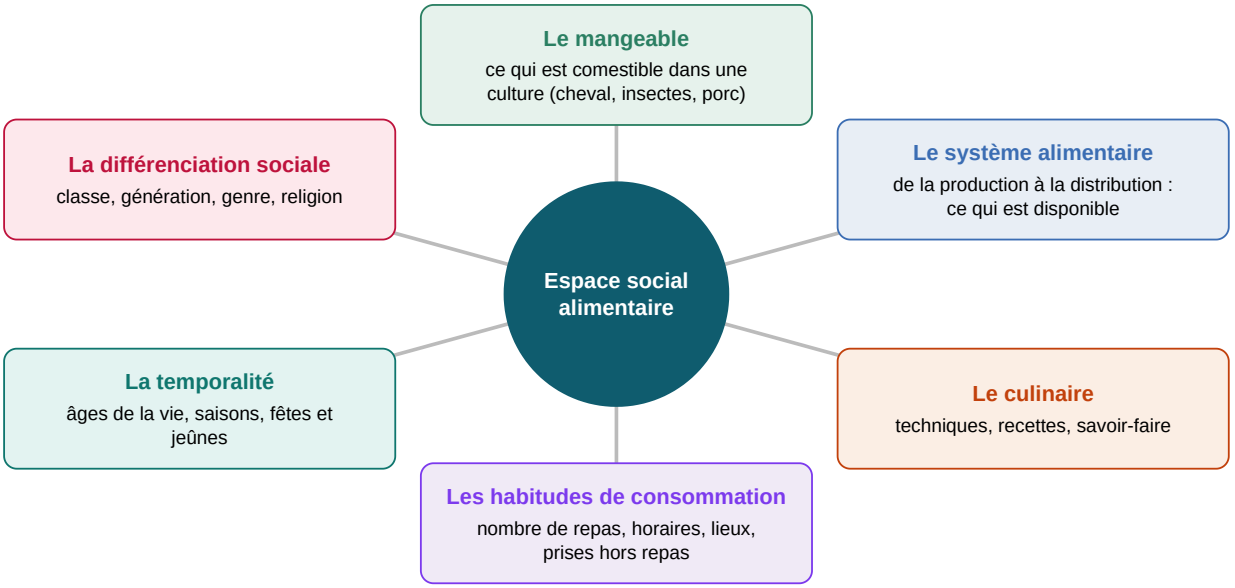
Les schémas du chapitre 3 à savoir refaire

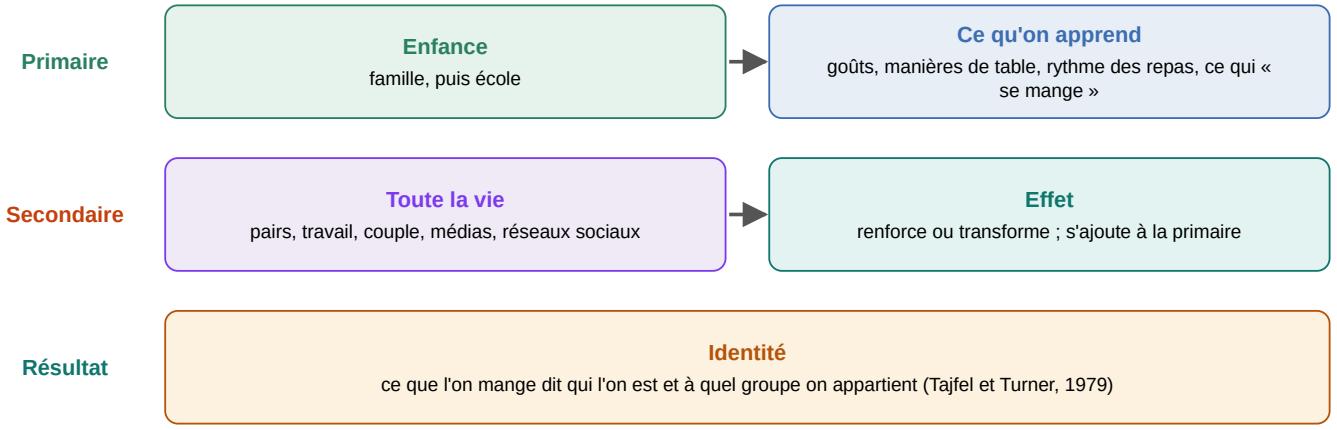
19 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Les six dimensions de l'espace social alimentaire (Poulain, 2002) (3.3.1, figure 3.1)



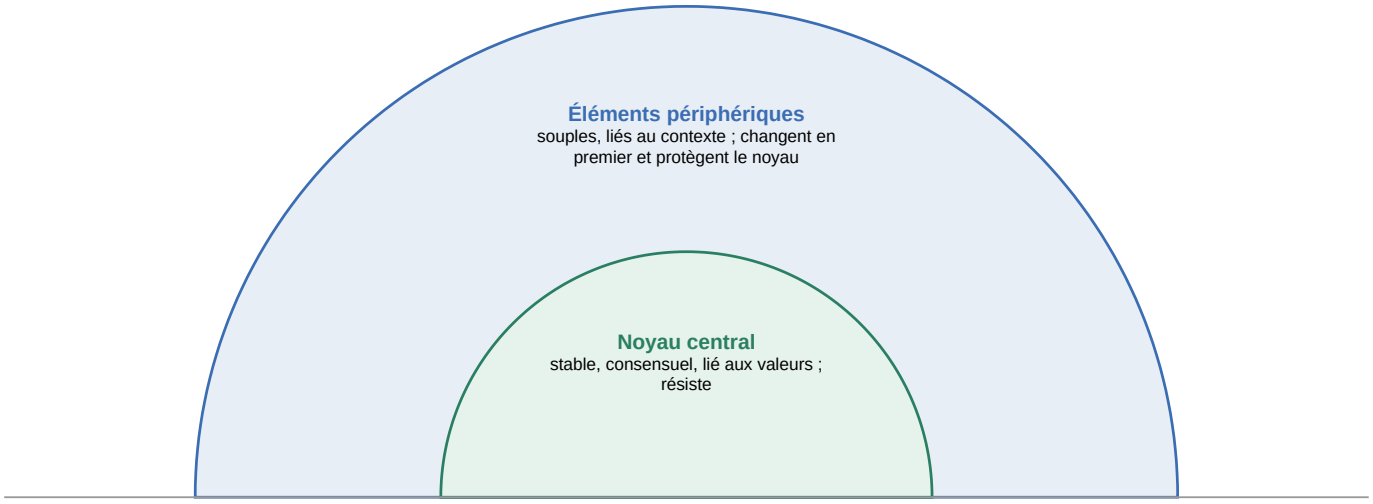
Dire : l'espace social alimentaire est la zone de liberté laissée au mangeur par les contraintes biologiques et environnementales. Un conseil nutritionnel touche à toutes ces dimensions : il est efficace s'il les respecte. Citer aussi Fischler 1990 (paradoxe de l'omnivore, incorporation).

2. Socialisation primaire et secondaire (3.3.2, figure 3.1 bis)



Dire : la socialisation est l'intériorisation des normes, valeurs et pratiques du groupe. Conséquence pour l'action : enfants → impliquer les parents ; adolescents → pairs et ambassadeurs ; adultes → partir des plats familiaux. Beaucoup d'adultes reviennent aux plats de l'enfance en devenant parents.

3. Le noyau central et la périphérie d'une représentation sociale (3.3.3 ; Moscovici 1961, Abric 1994)



on agit sur la périphérie en s'appuyant sur le noyau ; mise en cause : ≥ 75 % de « non » = élément central (Moliner, 1988)

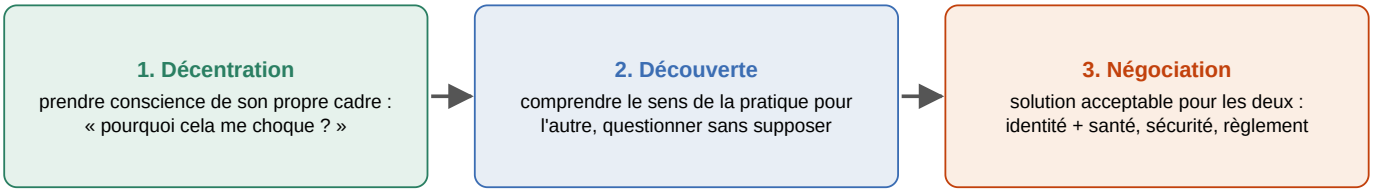
> Dire : une représentation sociale est un savoir de sens commun, partagé, qui oriente les conduites ; elle se forme par objectivation et ancrage ; 4 fonctions (savoir, identitaire, orientation, justificatrice). Ex. Tilleuls : noyau « un vrai repas = de la viande » → montrer un plat sans viande copieux et apprécié.

4. Les stratégies d'acculturation de Berry (1997) (3.3.3, figure 3.2 ; exercice 1 (figure 3.10))

	Contact avec la société d'accueil : OUI	Contact avec la société d'accueil : NON
Maintien de la culture d'origine : OUI	INTÉGRATION : garde ses plats et en adopte de nouveaux (la plus favorable)	SÉPARATION : plats d'origine seulement ; accès difficile aux produits
Maintien de la culture d'origine : NON	ASSIMILATION : abandon des plats d'origine ; produits transformés, sodas	MARGINALISATION : perte des repères ; grande vulnérabilité

> Dire : le modèle croise deux questions. Le diététicien favorise l'intégration en valorisant les pratiques d'origine favorables (légumineuses, légumes, cuisine maison) et en aidant à utiliser les produits disponibles. Acculturation : Redfield, Linton et Herskovits 1936 ; spontanée ou planifiée (Bastide).

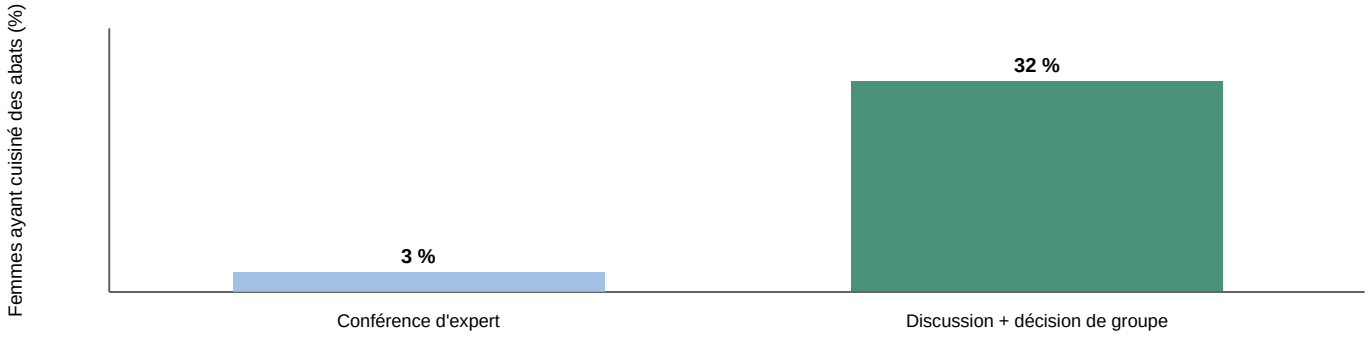
5. La démarche interculturelle en trois étapes (Cohen-Emerique, 2011) (3.3.3)



ex. ramadan d'un diabétique : orienter vers le médecin, travailler les repas de rupture et d'avant l'aube

> Dire : l'inverse est l'ethnocentrisme (juger avec ses propres normes). Le relativisme ne veut pas dire tout accepter. Ne pas réduire une personne à sa culture supposée : demander à tous « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas, pour des raisons de santé, de religion ou de goût ? ».

6. L'expérience de Lewin (1943) : conférence ou décision de groupe (3.3.4)



Dire : pendant la guerre, faire cuisiner des abats aux ménagères américaines. La participation et la décision collective publique (engagement) changent dix fois plus les pratiques que l'information descendante : fondement de l'approche participative.

7. La dissonance cognitive et ses trois issues (Festinger, 1957) (3.3.4, figure 3.2 bis)

Cognitions	**Connaissance** « les boissons sucrées favorisent le diabète »	**Comportement** « j'en bois un litre par jour »	**Dissonance** inconfort à réduire
Issues	**Changer le comportement** réduire les boissons sucrées (la seule utile)	**Changer la croyance** « ce n'est pas si grave »	**Ajouter une justification** « je fais du sport, ça compense »

Dire : les deux dernières issues sont les plus faciles ; un message culpabilisant sans moyen d'agir pousse au déni. Festinger et Carlsmith 1959 : payés 1 $, les étudiants changent d'avis plus que ceux payés 20 $ → une petite incitation engage plus qu'une grosse récompense.

8. Du stéréotype à la discrimination (3.3.4, figure 3.2 ter)

Stéréotype
croyance (pensée) : « les personnes en surpoids manquent de volonté »

→

Préjugé
attitude, jugement chargé d'émotion : mépris, gêne

→

Discrimination
comportement : traiter moins bien ; > 25 critères (art. 225-1 C. pénal)

stigmatisation (Goffman, 1963) : la personne est réduite à un attribut dévalorisé, qu'elle peut intérioriser

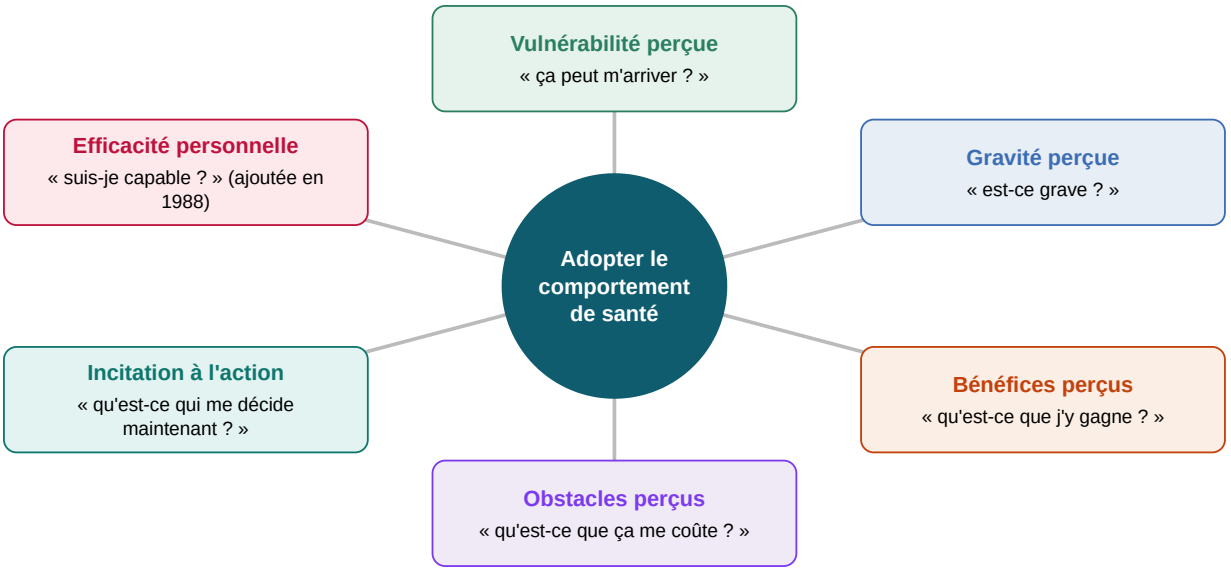
Dire : les flèches ne sont pas automatiques ; le cadre professionnel empêche le passage à l'acte. La stigmatisation du poids ne motive pas : stress, hyperphagie, évitement des soins (Puhl et Heuer). Menace du stéréotype (Steele et Aronson, 1995). Méthode : langage, images, cible, environnement, recrutement, relecture.

9. Les 9 compétences psychosociales générales (Santé publique France, 2022) (3.3.5, figure 3.3)

Cognitives	Émotionnelles	Sociales
• Avoir conscience de soi (connaissance de soi, pensée critique) • Capacité de maîtrise de soi • Prendre des décisions constructives	• Avoir conscience de ses émotions et de son stress • Réguler ses émotions • Gérer son stress	• Communiquer de façon constructive (écoute empathique) • Développer des relations constructives • Résoudre des difficultés (demander de l'aide, conflits)

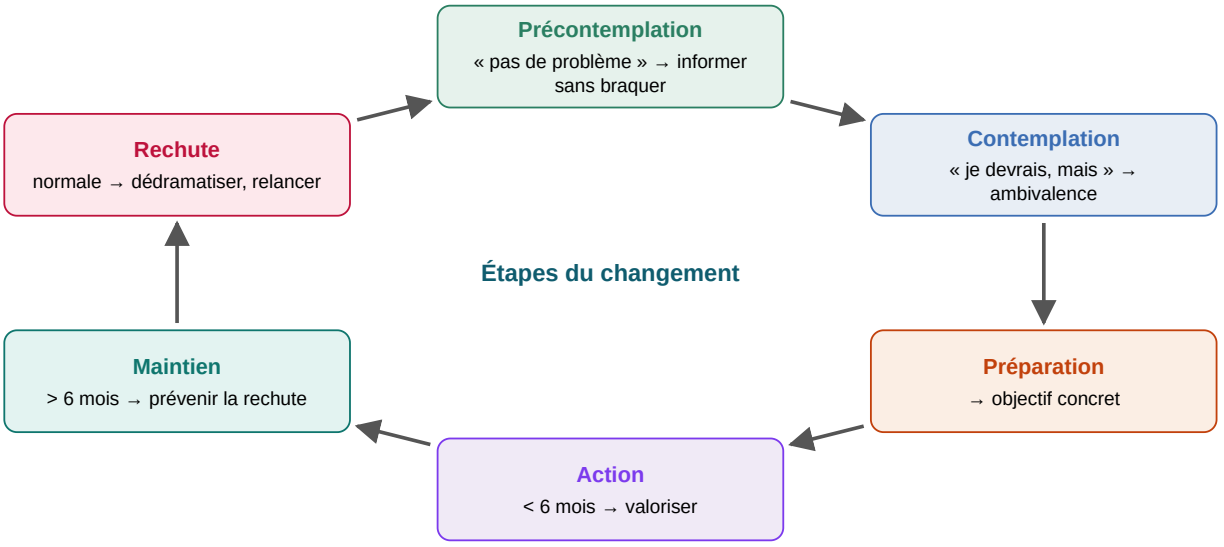
Dire : 3 catégories × 3 CPS générales, déclinées en une vingtaine de CPS spécifiques. OMS 1993 : 10 compétences en 5 couples. Stratégie interministérielle 2022-2037. Programmes efficaces = SAFE (Durlak, 2011) : séquencés, actifs, focalisés, explicites.

10. Le modèle des croyances relatives à la santé (HBM) (3.3.7 ; Rosenstock, Becker)



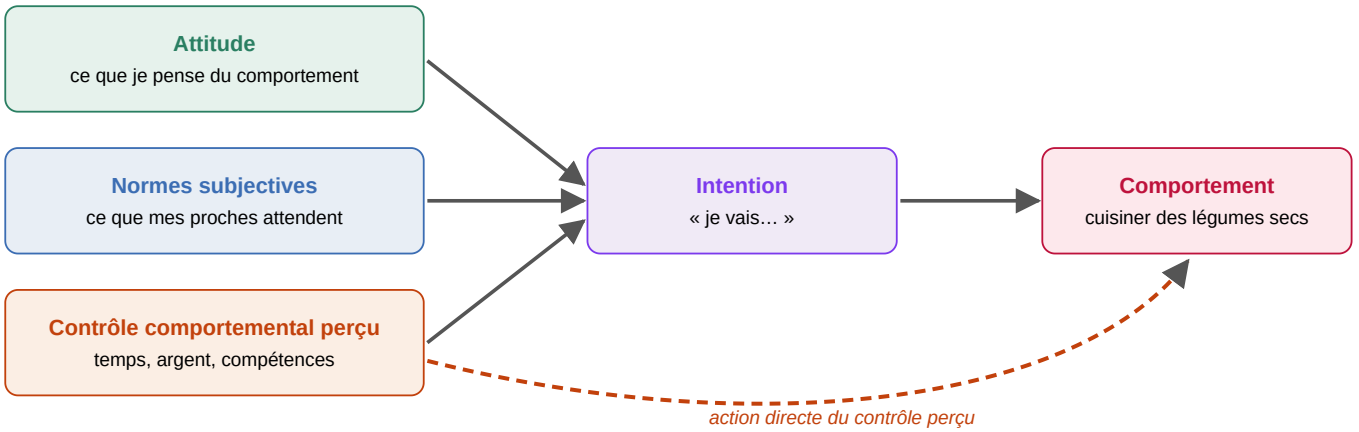
Dire : le modèle décrit une décision rationnelle ; il prédit mal les habitudes et donne peu de place aux normes et aux émotions. Il est surtout utile pour des comportements ponctuels et délibérés : dépistage, vaccination, consultation.

11. Les étapes du changement (Prochaska et DiClemente, 1983) (3.3.7, figure 3.4 ; exercice 2 (figure 3.11))



Dire : on adapte le discours à l'étape de chaque personne (outil O3.3). La rechute est une étape normale qui permet d'apprendre. Une personne qui a changé depuis 2 ou 3 mois est en action ; le maintien suppose plus de 6 mois.

12. La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) (3.3.7, figure 3.5)



Dire : les trois déterminants forment l'intention ; le contrôle perçu agit aussi directement sur le comportement : même avec une bonne intention, sans compétences ni moyens, rien ne se passe. D'où l'atelier où l'on cuisine. Écart intention-comportement : l'intention n'explique qu'environ 28 % du comportement (Sheeran, 2002) → plans « si…, alors… ».

13. Les 4 sources du sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 1977) (3.3.7)

1	**Expériences de réussite**	la plus forte : chacun réalise lui-même une étape, difficulté progressive
2	**Expériences vicariantes**	un pair qui me ressemble réussit : démonstration par un participant
3	**Persuasion verbale**	encouragements précis et sincères (« votre découpe est régulière »)
4	**États émotionnels**	état physiologique et émotionnel : ambiance détendue, pas de chronomètre, droit à l'erreur

Dire : l'efficacité personnelle est la croyance en sa capacité à réaliser une action précise ; c'est l'une des variables les plus liées au changement durable. On la mesure de façon spécifique (« je me sens capable de… », de 1 à 5, avant et après) ; échelle générale de Schwarzer et Jerusalem (1995).

14. Le schéma de la communication interpersonnelle (3.3.8, figure 3.5 bis ; Shannon et Weaver 1949)



bruits : physiques, linguistiques, culturels, psychologiques, sensoriels · rétroaction (feed-back) du récepteur vers l'émetteur

Dire : sans rétroaction, on informe, on ne communique pas ; vérifier par le teach-back (« dites-le-moi avec vos mots »), jamais par « avez-vous compris ? ». Palo Alto : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation. Porter : 6 attitudes, privilégier la compréhension.

15. Les étapes de la vie d'un groupe (Tuckman) (3.3.10, figure 3.6)

1	Formation	prudence, attente envers l'animateur → cadre, règles, brise-glace
2	Turbulence	désaccords normaux, signe d'implication → accueillir, dépasser
3	Normalisation	le groupe se donne des règles, la cohésion augmente
4	Production	coopération, initiatives ; l'animateur s'efface
5	Dissolution	fin de cycle : bilan, restitution, suite

Dire : connaître ces étapes évite de s'inquiéter d'une séance tendue (étape 2) et aide à préparer la fin. Style : participatif sur le contenu, directif sur le cadre (Lewin, Lippitt et White, 1939). Rôles : tâche, entretien du groupe, individualistes (Benne et Sheats, 1948).

16. Le continuum de l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985) (3.3.11, figure 3.7)

Amotivation	Externe	Introjectée	Identifiée	Intégrée	Intrinsèque
« ça sert à quoi ? »	« pour que le médecin arrête »	« je me sentirais coupable »	« c'est important pour ma santé »	« fait partie de qui je suis »	« j'adore, c'est un plaisir »

durabilité croissante · 3 besoins : autonomie, compétence, affiliation

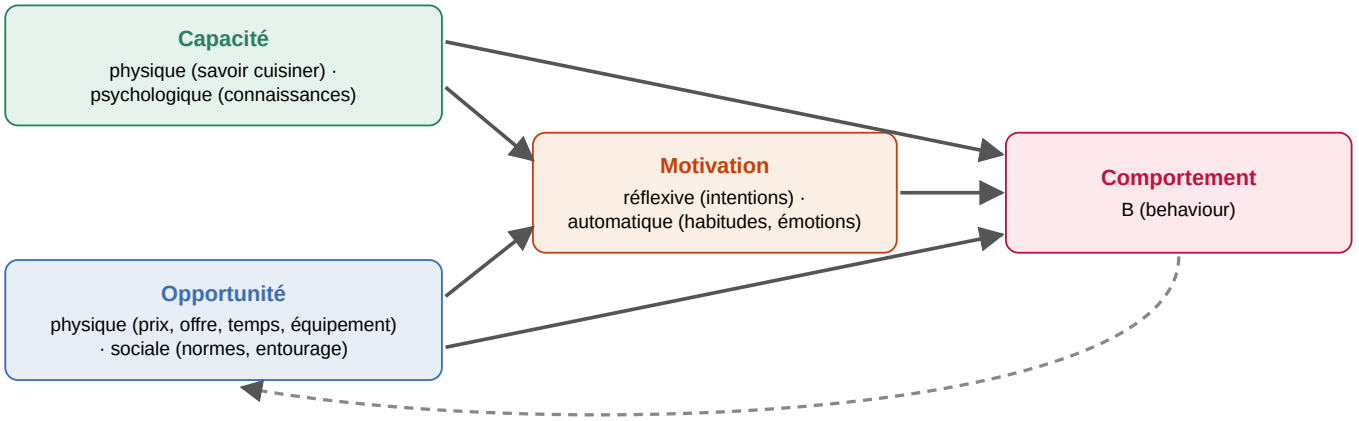
Dire : les motivations autonomes (identifiée, intégrée, intrinsèque) sont les plus durables. Effet de surjustification (Lepper, Greene et Nisbett, 1973) : une récompense attendue diminue la motivation intrinsèque → pas de « si tu manges tes légumes, tu auras un dessert ».

17. L'analyse prototypique d'une évocation (Vergès, 1992) (3.3.12, figure 3.8)

	Rang moyen < 2,30 (cité tôt)	Rang moyen ≥ 2,30 (cité tard)
Fréquence ≥ 10	NOYAU CENTRAL PROBABLE : cher, légumes, santé	1re PÉRIPHÉRIE : fruits, cuisiner
Fréquence < 10	ÉLÉMENTS CONTRASTÉS : régime, interdit	2e PÉRIPHÉRIE : temps, bio

Dire : rang moyen général = Σ(fréquence × rang) / Σ fréquences = 237,2 / 103 = 2,30 ; seuil de fréquence choisi (ici 10 sur 30 parents). Interprétation : l'équilibre est lié au coût → montrer qu'on peut manger équilibré à petit prix ; « régime » et « interdit » signalent un risque de restriction chez quelques-uns. Confirmer par une mise en cause.

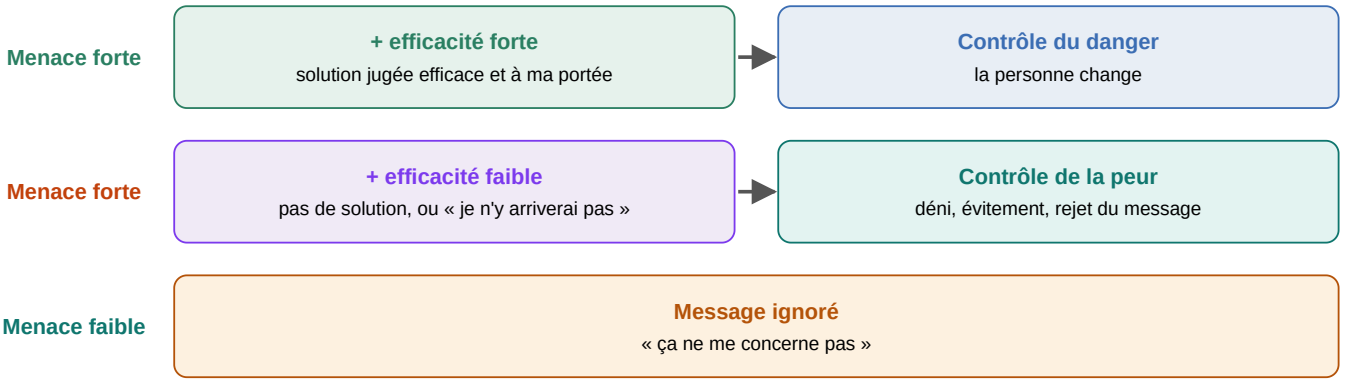
18. Le modèle COM-B (Michie, van Stralen et West, 2011) (3.3.13, figure 3.9)



le comportement installé renforce capacités et opportunités

Dire : le diagnostic identifie la composante qui manque, puis on choisit la fonction d'intervention : éducation, persuasion, incitation, coercition, formation, restriction, restructuration de l'environnement, modélisation, facilitation. Si le frein est l'opportunité, une action d'information échoue. 93 techniques de changement (taxonomie de 2013).

19. Message qui fait peur : le modèle des processus parallèles (Witte, 1992) (3.4.6)



Dire : un message qui fait peur doit toujours être accompagné d'une solution concrète et à la portée de la personne ; auprès des publics vulnérables, on préfère les messages positifs. Normes : afficher une norme descriptive défavorable provoque un effet boomerang (Schultz, 2007 ; Cialdini, 2003).